

Rodzice są zasobem — *złoty standard dla młodzieży*

FBT to terapia pierwszego wyboru dla adolescentów z AN (NICE NG69, AAP, AED). Trzy fazy. Rodzice są partnerami w refeedingu, nie obwiniani.

CZAS: 6–12 miesięcy, 15–20 sesji rodzinnych

REALIZACJA: adolescenti 10–18 lat (możliwa adaptacja dla młodych dorosłych)

ŹRÓDŁO: Lock & Le Grange (2013, *Treatment Manual for AN*); Lock i in. (2010, RCT); NICE NG69 (2017, rekomendacja A); AAP (2021)

JAK UŻYWAĆ

Sekcja 01 — **trzy fazy FBT** (refeeding kierowany przez rodziców → przeniesienie kontroli → tożsamość adolescenta). Sekcja 02 — **siedem zasad pracy** (zewnętrzność AN, rodzic-zasób, brak winy, agnostyzm etiologiczny). Sekcja 03 — **karta rodziny**.

DLACZEGO TO DZIAŁA

FBT — *Family-Based Treatment*, zwana też *Maudsley approach* (Lock & Le Grange, 2013). **Status:** terapia pierwszego wyboru dla adolescentów z AN — rekomendacja A w NICE NG69 (2017), AAP (2021), AED (2021). RCT Lock i in. (2010): FBT istotnie skuteczniejsza od indywidualnej psychoterapii adolescentów po 12 miesiącach. **Główne założenia:** (1) AN jest zewnętrzną wobec adolescenta (eksternalizacja); (2) rodzice są zasobem, nie problemem — biorą czynną odpowiedzialność za refeeding w fazie 1; (3) terapeuta jest konsultantem, nie głównym agentem zmiany; (4) agnostyzm etiologiczny — nie szukamy „dlaczego AN”; (5) brak obwiniania rodziców. **Krytyczne:** FBT nie jest „rodzina jako problem” — jest „rodzina jako rozwiązanie”. Wymaga formalnego szkolenia.

01 Trzy fazy FBT — co się dzieje w każdej

FAZA

CEL I KONKRETNA PRACA

FAZA 1 (sesje 1–10) Refeeding pod kierownictwem rodziców

Rodzice biorą czynną odpowiedzialność za jedzenie adolescenta. Sesja rodzinnego posiłku (ang. *family meal*) (sesja 2): rodzice przynoszą posiłek, terapeuta obserwuje i wspiera. Cel: przywrócenie 80–90% docelowej masy. Pacjent *nie wybiera*, co i ile je — to rodzice.

*FAZA 2 (sesje 11–16)
Stopniowe przeniesienie kontroli*

Po osiągnięciu ~90% wagi i stabilności medycznej — adolescent stopniowo odzyskuje kontrolę nad jedzeniem. Małe kroki: porcja śniadania, potem cały posiłek, potem wybór. Rodzice *nadzorują*, nie dominują.

*FAZA 3 (sesje 17–20)
Tożsamość adolescenta + zakończenie*

Praca nad rozwojowymi zadaniami adolescencji, które AN zablokowała: autonomia, tożsamość, relacje rówieśnicze, plany na przyszłość. Rodzice wracają do roli „typowych rodziców nastolatka”. Plan profilaktyki nawrotu.

Rodzinny posiłek (ang. *family meal*) w sesji 2 — kluczowy moment FBT. Rodzice przynoszą jedzenie, jedzą wspólnie z adolescentem, próbują „zachęcić” jednego dodatkowego kęsa. Terapeuta obserwuje dynamikę, wspiera, koryguje. To nie ćwiczenie — to symboliczny moment przejęcia odpowiedzialności przez rodziców.

02 ☉ Siedem zasad pracy w FBT

1. **Eksternalizacja AN** — od pierwszej sesji: „*To nie nasza córka/syn — to AN próbuje ją/go zabić. Walczymy razem przeciwko AN, nie przeciwko adolescentowi*”. Zmniejsza krytycyzm rodziców i opór adolescenta.
2. **Rodzice jako zasób** — nie „rodzina dysfunkcyjna”, nie „winni”. Rodzice wiedzą, jak nakarmić własne dziecko — robili to przez lata. AN zabrała im pewność. Terapeuta przywraca: „*wy jesteście ekspertami w nakarmieniu tego dziecka*”.
3. **Agnostyzm etiologiczny** — nie szukamy „dlaczego AN”. Skupiamy się na *tu i teraz*: jak nakarmić, jak odzyskać wagę. Pytania o etiologię odsuwa się na fazę 3 lub późniejszą.
4. **Wybór posiłków = rodzice** (faza 1) — bez negocjacji, bez „*co chcesz zjeść?*”. Rodzice decydują, co i ile. To kosztowne emocjonalnie — terapeuta wspiera rodziców tygodniowo.
5. **Bez obwiniania nikogo** — ani adolescenta („*oporny/-a*”), ani rodziców („*nadopiekuńczy*”). AN jest celem walki. Krytycyzm rodziców predyktorem gorszego rokowania.
6. **Wspólne sesje rodzinne** — wszyscy domownicy obecni (rodzice, rodzeństwo, czasem dziadkowie jeśli mieszkają). Rodzeństwo nie bierze odpowiedzialności za refeeding, ale wspiera.
7. **Terapeuta jako konsultant** — nie jako „*ten, który leczy*”. Terapeuta strukturyzuje pracę, edukuje, wspiera — ale to rodzice doprowadzają do refeedingu. Terapeuta nie staje się centralną figurą.

03 Karta rodziny w FBT — wstępne ustalenia

SKŁAD RODZINY OBECNY NA SESJI

— rodzice, rodzeństwo, czasem dziadkowie; wszyscy domownicy

KTO BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA POSIŁKI W FAZIE 1

— oboje rodzice (preferowane), jeden rodzic, podział, koordynacja

AKTUALNA MASA ADOLESCENTA + DOCELOWA

— pomiar z dietetykiem ED; 50. percentyl dla wieku/wzrostu lub indywidualnie

GŁÓWNE OBAWY RODZICÓW

— bezpieczeństwo medyczne, opór adolescenta, własne kompetencje, koszty emocjonalne, praca, inni członkowie rodziny

Klucz: FBT to złoty standard dla adolescentów z AN — żaden inny model nie ma tak silnej bazy empirycznej w tej grupie. Wymaga jednak zaangażowanej rodziny (oboje rodzice obecnych emocjonalnie, zdolnych do koordynacji posiłków) i formalnego szkolenia terapeuty (FBT-certified).
Komunikat dla rodziców: „*nie zrobiliście tego — AN zaatakowała Wasze dziecko, jak choroba. Macie umiejętności, których AN się boi — Wy znacie to dziecko od urodzenia. W ciągu najbliższych miesięcy będziecie pierwszą linią walki. To jest trudne. To jest możliwe. Robimy to razem*”.

⚠ **Ograniczenia FBT:** nie dla rodzin z aktywną przemocą, czynną psychopatologią ciężką u rodzica (ciężka depresja, uzależnienie), bardzo wysokim ekspresjonowanym krytycyzmem (EE — wskaźnik gorszego rokowania). W tych przypadkach: jeden-rodzic FBT (Parent-Focused Therapy), Multifamily FBT (w grupie kilku rodzin), lub indywidualna AFT (Adolescent-Focused Therapy) jako alternatywy.